

Diabetes gestacional - rastreio e metas

DMG aumenta macrosomia, distocia e DM futuro. Rastreie no pré-natal, trate com terapia médica nutricional e inicie insulina se metas falharem.

Diagnóstico (conceito)

Dica - Diagnóstico (conceito)

TOTG 75 g: pontos de corte em jejum/1 h/2 h conforme IADPSG/MS. Um valor alterado já diagnostica em muitos protocolos.

Do TOTG no 2º trimestre ao reteste puerperal — a banca ama o follow-up.



Manejo

- Automonitorização; metas de jejum e pós-prandiais rigorosas
- Insulina é padrão se dieta insuficiente; metformina em protocolos selecionados
- USG para crescimento; atenção a polidrâmnio e macrosomia
- RN: risco de hipoglicemia neonatal — aleitamento precoce

Complicações

Momento | Risco

Fetal/neonatal | Macrosomia, hipoglicemia, icterícia

Parto | Distocia de ombro, laceração, cesárea

Materno | HAS/pré-eclâmpsia, infecção

Longo prazo | DM2 materno; obesidade na prole

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não 'liberar' sem reteste puerperal — muitas persistem com DM/intolerância. Hiperglicemia no 1º trimestre: pense DM prévio desconhecido, não só DMG.